

БЕКТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары
жана медициналык буюмдар
департаментинин
директорунун орун басары
Абдиев М.К.
«27» июнь 2023-ж.

ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

ФОРЦИП

Соодадагы аталышы: Форцип.

Эл аралык патенттелбеген аталышы: ципрофлоксацин.

Дарынын түрү: ичип кабыл алуу үчүн суспензия.

Курамы: ар бир 5 мл төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Ципрофлоксацин гидрохлориди ВР 125 мг ципрофлоксацинге туура келет

Көмөкчү заттар: индион 234, сахароза, метилпарабен, пропилпарабен, гуар чайыры, глицерин, сорбитол эритмеси, натрий бензоаты, сорбин кислотасы, алюминий хлориди, аспартам, сары хинолин боёгучу (Супра), полисорбат 80, ванилденген ачык сары кызгылт эсс., шоколад эсс., тазартылган суу.

Сүрөттөмөсү: Сары түстөгү суспензия.

Фармадарылык тобу: Системалуу колдонуу үчүн микробго каршы препараттар. Системалуу колдонуу үчүн бактерияга каршы препараттар. Бактерияга каршы препараттар – хинолондон алынгандар. Фторхинолондор. Ципрофлоксацин.

АТХ коду: J01MA02.

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикасы:

Ципрофлоксацин (1-циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-пиперазин-1-ил-хинолон-3-карбон кислотасы, гидрохлорид) — фторхинолондор тобундагы микробго каршы препарат. Таасир берүү механизми бактериялардын ДНК-гираза ферментин басаңдатуу

жана ДНК синтезин бузуусу менен шартталган. Ципрофлоксацин грам оң жана грам терс бактерияларга, анын ичинде пенициллиндерге туруктуу штаммдарга, цефалоспориндерге жана аминогликозиддерге карата активдүү. Ципрофлоксацин микроорганизмдердин кенири чөйрөсүнө карата активдүү:

аэробдуу грам терс бактериялар — *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Salmonella* spp., *Proteus* spp., *Shigella* spp., *Yersinia* spp., *Enterobacter* spp., *Morganella morganii*, *Providencia* spp., *Vibrio* spp., *Citrobacter* spp., *Serratia* spp., *Campylobacter* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *P. cepacia*, *Neisseria gonorrhoeae*, *N. meningitidis*, *Haemophilus influenzae*, *H. ducreyi*, *Acinetobacter* spp., *Moraxella catarrhalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Pasteurella multocida*, *Helicobacter pylori*; аэробдуу грам оң бактериялар — стафилококктор, анын ичинде пенициллиназаны пайда кылган штаммдар, жана метициллинге туруктуу штаммдар; стрептококктор, анын ичинде *Streptococcus pneumoniae*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium* spp. Препаратка сезгич эместер анаэробдуу бактериялар, риккетсиялар, *Nocardia asteroides*, кубарган спирохет, вирустар, мите козу карындар жана жөнөкөйлөр.

Фармакокинетикасы:

Ципрофлоксацин пероралдуу кабыл алуудан кийин тез сиңет, анын биожеткиликтүүлүгү дээрлик 70% түзөт. Тамак препараттын сиңүү деңгээлине таасир бербейт, бирок сиңүү ылдамдыгын бир нечеге төмөндөтүшү мүмкүн. Ылайыгына жараша 250 жана 500 мг дозасында ичкенден кийин 1–2 саат ичинде кан плазмасындагы ципрофлоксациндин C_{max} 1,5 жана 2,5 мкг/мл жетет. T_{1/2} — 3,5–4,5 саат; боор циррозунда; оор бөйрөк алсыздыгы учурунда 8 саатка чейин көбөйөт. Муковисцидозу бар оорулууларда ципрофлоксациндин фармакокинетикасы өзгөрбөйт. Препарат организмдин дээрлик бардык ткандарында жана биологиялык суюктуктарында дарылык концентрацияларга жетет. Ципрофлоксациндин кан плазмасынын белоктору менен байланышуусу төмөн - 19–40%. Ципрофлоксацин эне сүтүнө жана бала тону аркылуу өтөт. Препараттын 40–50% өзгөрүлбөгөн түрдө заара менен, 15% жакыны – метаболиттер түрүндө бөлүнүп чыгат. Препараттын болжолдуу 20–35% заң менен бөлүнүп чыгат.

Колдонууга көрсөтмө:

Дарылоону баштоонун алдында ципрофлоксацинге микроорганизмдердин туруктуулугу тууралуу болгон маалыматка өзгөчө көңүл буруу керек.

Бактерияга каршы каражаттарды туура колдонуу боюнча расмий колдонмону кароо керек.

Чоң адамдар:

- Грам терс бактериялардан пайда болгон дем алуу жолдорунун төмөнкү бөлүктөрүнүн инфекциялары:

- өпкөнүн өнөкөт кептелме ооруларынын күчөшү.

Өпкөнүн өнөкөт кептелме оорулары курчуусунда ципрофлоксацинди адатта бул инфекцияларды дарылоо үчүн сунушталган башка бактерияга каршы каражаттарды колдонуу максатка ылайыктуу эмес деп эсептелгенде гана колдонуу керек.

- муковисцидоздо же бронхоэктаздарда колко өпкө инфекциялары;

- пневмония.

- Өнөкөт ириндүү ортоңку отит;
- Өнөкөт синуситтин курч күчөшү, өзгөчө ал грам терс бактериялардан пайда болсо;
- Заара чыгаруучу түтүктүн инфекциясы

- татаалдашпаган курч цистит.

Татаалдашпаган курч циститте ципрофлоксацинди адатта бул инфекцияларды дарылоо үчүн сунушталган башка бактерияга каршы каражаттарды колдонуу максатка ылайыктуу эмес деп эсептелгенде гана колдонуу керек.

- Курч пиелонефрит
- Заара бөлүп чыгаруу жолдорунун татаалдашкан инфекциялары
- Бактериялык простатит
- Жыныс жолдорунун инфекциялары:
 - сезгич *Neisseria gonorrhoeae* пайда кылган гонококк уретрити жана цервицит;
 - эпидидимоорхит, анын ичинде сезгич *Neisseria gonorrhoeae* кылган учурлар;
 - кичи жамбаш чарасынын сезгенген оорулары, анын ичинде сезгич *Neisseria gonorrhoeae* пайда кылган учурлар.
- Ашказан-ичеги жолунун инфекциялары (мисалы, саякатчылардын ич өткөгү)
- Интраабдоминалдык инфекциялар
- Грам терс бактериялардан пайда болгон теринин жана жумшак ткандардын инфекциялары
- Залалдуу сырткы отит
- Сөөктөрдүн жана муундардын инфекциялары
- *Neisseria meningitidis* пайда болгон инвазиялык инфекцияларды алдын алуу.
- Сибирь жарасынын өпкө формасы (контакттан кийинки алдын алуу жана радикалдык дарылоо).

Ципрофлоксацин бактериялык инфекциядан болжолдуу пайда болгон нейтропениясы жана калтыратмасы бар бейтаптарды дарылоо үчүн колдонууга болот.

Балдар жана өспүрүмдөр:

- Муковисцидозу бар бейтаптарда *Pseudomonas aeruginosa* пайда кылган колко өпкө инфекциялары.
- Заара бөлүп чыгаруу жолдорунун татаалдашкан инфекциялары жана курч пиелонефрит
- Күйдүргүнүн өпкө формасы (контакттан кийинки алдын алуу жана радикалдык дарылоо).

Ципрофлоксацинди ошондой эле бул зарыл деп эсептелсе, балдарда жана өспүрүмдөрдө оор инфекцияларды дарылоо үчүн колдонууга болот.

Дарылоо балдарда жана өспүрүмдөрдө муковисцидозду жана/же оор инфекцияларды дарылоо тажрыйбасы болгон дарыгерлер менен башталышы керек.

Каршы көрсөтмө:

- Таасир берүүчү затка, башка хинолондорго же көмөкчү заттардын кайсы бирине жогору сезгичтик;
- Ципрофлоксацинди жана тизанидинди бир убакта ичүү.

Колдонуу жолу жана дозасы:

Дозалоо.

Дозасы көрсөтмөсү, инфекциянын оордугу жана орду, ципрофлоксацинге козгогучтун сезгичтиги, бейтаптын бөйрөгүнүн функциясына, ошондой эле балдарда жана өспүрүмдөрдө дене салмагына жараша аныкталат.

Дарылоонун узактыгы оорунун оордугуна, клиникалык жана бактериологиялык өтүшүнө көз каранды.

Кээ бир бактериялардан (мисалы, *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter* же *Staphylococci*) пайда болгон инфекцияларды дарылоо ципрофлоксациндин жогору дозаларын жана бир убакта башка тиешелүү бактерияга каршы каражаттар менен колдонууну талап кылышы мүмкүн.

Кээ бир инфекцияларды дарылоо (мисалы, кичи жамбаш чарасынын органдарынын сезгенген оорулары, интраабдоминалдык инфекциялар, нейтропениясы жана сөөк жана муундардын инфекциялары бар бейтаптарда инфекциялар) пайда кылган козгогучтарга жараша бир убакта башка тиешелүү бактерияга каршы каражаттар менен колдонууну талап кылышы мүмкүн.

Чоң адамдар

Төмөнкү дем алуу жолдорунун инфекциялары - суткасына 2 жолу 500 мг.дан баштап суткасына 2 жолу 750 мг.га чейин (күнүнө эки жолу 20 мл.ден баштап күнүнө эки жолу 30 мл.га чейин). Дарылоонун жалпы узактыгы (мүмкүн, анын ичинде ципрофлоксацин менен баштапкы парентералдык дарылоо) – 7ден 14 күнгө чейин.

Үстүңкү дем алуу жолдорунун инфекциялары:

Өнөкөт синуситтин курч күчөшү, өнөкөт ириндүү ортоңку отит - 500 мг.дан суткасына 2 жолу 750 мг.га чейин суткасына 2 жолу (20 мл.ден күнүнө эки жолу 30 мл.ге чейин күнүнө эки жолу). Дарылоонун жалпы узактыгы (мүмкүн, анын ичинде ципрофлоксацин менен баштапкы парентералдык дарылоо) – 7ден 14 күнгө чейин.

Залалдуу сырткы отит - 750 мг суткасына 2 жолу (30 мл күнүнө эки жолу). Дарылоонун жалпы узактыгы (мүмкүн, анын ичинде ципрофлоксацин менен баштапкы парентералдык дарылоо) – 28 күндөн 3 айга чейин.

Заара бөлүп чыгаруу жолдорунун инфекциялары:

Татаалдашпаган курч цистит - күнүнө 2 жолу 250 мг.дан суткасына 2 жолу 500 мг.га чейин (10 мл.ден күнүнө эки жолу 20 мл.ге чейин күнүнө эки жолу) - 3 күн. Менопаузадагы аялдарга бир жолку 500 мг дозасын колдонууга болот, ал бир жолку 20 мл дозасына ылайык келет.

Татаалдашкан цистит, курч пиелонефрит - 500 мг күнүнө эки жолу (20 мл күнүнө эки жолу) -7 күн.

Татаалдашкан пиелонефрит - 500 мг.дан баштап суткасына 2 жолу 750 мг.га чейин суткасына 2 жолу (20 мл.ден баштап күнүнө эки жолу 30 мл.ге чейин күнүнө эки жолу), 10 күндөн кем эмес, кээ бир өзгөчө кырдаалдарда (мисалы, ириндөөлөрдө) аны 21 күндөн ашык колдонууга болот.

Бактериялык простатит - 500 мг.дан баштап суткасына 2 жолу 750 мг.га чейин суткасына 2 жолу (10 мл.ден баштап күнүнө эки жолу 15 мл.ге чейин күнүнө эки жолу), 2ден 4 жумага чейин (курч) 4-6 жумага чейин (өнөкөт).

Жыныс жолдорунун инфекциялары:

Сезгич Neisseria gonorrhoeae пайда болгон Gonococcal urethritis жана цервицит - 500мг бир жолку доза түрүндө (20 мл бир жолку доза түрүндө), 1 күн (бир жолку доза).

Эпидидимоорхит жана кичи жамбаш чарасынын органдарынын сезгенген оорулары, анын ичинде сезгич Neisseria gonorrhoeae пайда болгон учурлар - 500 мг.дан баштап суткасына 2 жолу 750 мг.га чейин суткасына 2 жолу (20 мл.ден баштап күнүнө эки жолу 30 мл.ге чейин күнүнө эки жолу), эң аз дегенде 14 күн.

Ашказан-ичеги жолунун инфекциялары жана курсак ичиндеги инфекциялар:

Бактериялык патогендерден пайда болгон ич өткөк, анын ичинде *Shigella spp.* 1 типтеги *Shigella dysenteriae* жана саякатчылардын оор ич өткөгүн эмпирикалык дарылоодон тышкары: 500 мг күнүнө эки жолу (20 мл күнүнө эки жолу), 1 күн.

1 типтеги *Shigella dysenteriae* пайда болгон ич өткөк - 500 мг күнүнө эки жолу (20 мл күнүнө эки жолу), 5 күн.

Vibrio cholera пайда болгон ич өткөк - 500 мг күнүнө эки жолу (20 мл күнүнө эки жолу), 3 күн.

Келте калтыратмасы – 500 мг күнүнө эки жолу (20 мл күнүнө эки жолу), 7 күн.

Грам терс бактериялар пайда кылган курсак ичиндеги инфекциялар - 500 мг.дан баштап суткасына 2 жолу 750 мг.га чейин суткасына 2 жолу (20 мл.ден күнүнө эки жолу 30 мл.ге чейин күнүнө эки жолу), 5тен 14 күнгө чейин.

Грам терс бактериялар пайда кылган теринин жана жумшак ткандардын инфекциялары:

500 мг.дан баштап суткасына 2 жолу 750 мг.га чейин суткасына 2 жолу (20 мл.ден баштап күнүнө эки жолу 30 мл.ге чейин күнүнө эки жолу), 7ден 14 күнгө чейин.

Сөөктөрдүн жана муундардын инфекциялары: 500 мг.дан баштап суткасына 2 жолу 750 мг.га чейин суткасына 2 жолу (20 мл.ден күнүнө эки жолу 30 мл.ге чейин күнүнө эки жолу). Дарылоонун жалпы узактыгы (мүмкүн, анын ичинде ципрофлоксацин менен баштапкы парентералдык дарылоо) – эң көп дегенде 3 айга чейин.

Божомолдуу бактериялык инфекциядан пайда болгон нейтропениясы жана калтыратмасы бар бейтаптар.

Ципрофлоксацинди расмий колдонмосуна ылайык тиешелүү бактерияга каршы каражат (тар) менен бир убакта колдонуу керек.

500 мг.дан баштап суткасына 2 жолу 750 мг.га чейин суткасына 2 жолу (20 мл.ден баштап күнүнө эки жолу 30 мл.ге чейин күнүнө эки жолу). Дарылоону нейтропениянын бардык мезгили ичинде улантуу керек.

***Neisseria meningitidis* пайда кылган инвазиялык инфекцияларды алдын алуу:** 500 мг бир жолку дозасы түрүндө (20 мл бир жолку доза түрүндө), күнүнө 1 жолу (бир жолку доза).

Клиникалык жактан максатка ылайыктуу болгондо, пероралдуу жол менен дарылоону ала турган адамдар үчүн сибирь жарасынын өпкө формасын контактан кийин алдын алуу жана дарылоо.

Препаратты куюуну божомолдонгон же тастыкталган таасирден кийин болушунча тез баштоо керек.

500 мг күнүнө эки жолу (20 мл күнүнө эки жолу), *Bacillus anthracis* менен байланышы такталган учурдан тартып 60 күн.

Балдар популяциясы

Ыйлаакчалуу фиброз: 20 мг/кг дене салмагына дозасына 750 мг эң жогорку дозасы менен күнүнө эки жолу, 10дон 14 күнгө чейин.

Заара бөлүп чыгаруу жолдорунун татаалдашкан инфекциялары жана пиелонефрит: дене салмагынын кг.на 10 мг күнүнө эки жолу дене салмагынын кг.на 20 мг.га чейин күнүнө эки жолу дозасына эң жогорку дозасы 750 мг күнүнө эки жолу, 10дон 21 күнгө чейин.

Клиникалык жактан максатка ылайыктуу болгондо, пероралдуу жол менен дарылоону ала турган адамдар үчүн сибирь жарасынын өпкө формасын контактан кийин алдын алуу жана дарылоо.

Препаратты куюуну божомолдонгон же тастыкталган таасирден кийин болушунча тез баштоо керек. Дене салмагынын кг.на 10 мг.дан күнүнө эки жолу дене салмагынын кг.на 15 мг.га чейин күнүнө эки жолу дозасына 500 мг эң жогорку дозасы менен, *Bacillus anthracis* менен байланышы такталган учурдан тартып 60 күн.

Башка оор инфекциялар: дене салмагынын кг.на 20 мг дозасына 750мг эң жогорку дозасы менен инфекциянын тибине жараша.

Улгайган бейтаптар

Улгайган бейтаптар инфекциянын оордугуна жана бейтаптын креатинин клиренсине жараша тандалган дозаны алуусу керек.

Бөйрөк жана боор алсыздыгы бар бейтаптар

Бөйрөк функциясынын бузулуусу бар бейтаптар үчүн сунушталган баштапкы жана колдоочу дозалары:

Креатинин клиренси [мл/мин / 1,73 м ²]	Сары суу креатинини [мкмоль / л]	Пероралдуу дозасы [мг]
> 60	<124	Адаттагы дозасын караңыз.
30-60	124төн 168ге чейин	250-500 мг ар бир 12 саатта
<30	> 169	250-500 мг ар бир 24 саатта
Гемодиализдеги бейтаптар	> 169	250-500 мг ар бир 24 саатта (диализден кийин)
Перитонеалдык диализдеги бейтаптар	> 169	250-500 мг ар бир 24 саатта

Боор функциясынын бузулуусу бар бейтаптарда дозаны тууралоо талап кылынбайт.

Бөйрөк жана /же боор функциясынын бузулуулары бар балдарда дозасы изилденген эмес.

Колдонуу жолу

Суспензияны тамак ичүүгө көз карандысыз кабыл алууга болот.

Эгерде дозасы өткөрүлүп кетсе, аны кийинки пландалган дозага чейин 6 саат мурундан кеч эмес каалаган убакта кабыл алуу керек. Эгерде кийинки дозаны ичүүгө 6 сааттан аз калса, өткөрүлгөн дозаны кабыл алууга болбойт, ал эми дарылоону кийинки пландалган дозасы менен дарыгердин дайындоосуна ылайык улантуу керек. Өткөрүлгөн дозаны толуктоо үчүн эки дозаны кабыл алууга болбойт.

Ачкарын ичүүдө таасир берүүчү зат тезирээк сиңет. Ципрофлоксацинди сүт азыктары (мисалы, сүт, йогурт) же минералдар менен байытылган жемиш ширелери (мисалы, кальций менен байытылган апельсин ширеси) менен кабыл алууга болбойт.

Оор учурларда же эгерде бейтап пероралдуу суспензияны иче албаган учурда (мисалы, энтералдык тамактанган бейтаптар) дарылоону пероралдуу ичүүгө өтүүгө мүмкүн болгонго чейин ципрофлоксацинди тамыр ичине куюудан баштоо сунушталат.

Кыйыр таасирлери:

Көбүнчө билдирилген жагымсыз дары реакциялардан (ADRs) болуп көңүл айнуу жана ич өтүү эсептелет.

Клиникалык изилдөөлөрдүн жана ципрофлоксацинди (пероралдуу, тамыр ичине жана баскычтуу дарылоо) маркетингден кийинки байкоонун натыйжасында алынган, жыштык категориясы боюнча сорттолгон жагымсыз реакциялар. Жыштыгын талдоо

ципрофлоксацинди пероралдуу да, ошондой эле тамыр ичине куюудагы маалыматтарды эске алат.

Инфекциялык жана мителик оорулар: Көп эмес – Микотикалык суперинфекциялар.

Кан жана лимфа системасы тарабынан бузулуулар: Көп эмес – эозинофилия. Сейрек – лейкопения, аз кандуулук, нейтропения, лейкоцитоз, тромбоцитопения, тромбоцитемия. Абдан сейрек – гемолитикалык аз кандуулук, агранулоцитоз, панцитопения (өмүр үчүн коркунучтуу), чучук затынын ишин басуу (өмүр үчүн коркунучтуу).

Иммундук система тарабынан бузулуулар: сейрек – аллергиялык реакция, аллергиялык шишимик /ангионевротикалык шишимик. Абдан сейрек – анафилактикалык реакция, анафилактикалык шок (өмүр үчүн коркунучтуу), сары суу оорусуна окшогон реакция.

Эндокриндик системасы тарабынан бузулуулар: Жыштыгы белгисиз – антидиуретикалык гормондун адекваттуу эмес продукциясы синдрому (SIADH).

Зат алмашуу жана тамактануу тарабынан бузулуулар: Көп эмес – табиттин төмөндөшү. Сейрек – гипергликемия, гипогликемия. Жыштыгы белгисиз – гипогликемиялык кома.

Психикалык бузулуулар: Көп эмес – психомотордук гиперактивдүүлүк/дүүлүгүү. Сейрек – чаташуу жана багытын жоготуу, тынчсыздануу реакциясы, уйкунун бузулуусу, чүнчүү (өзүн өлтүрүү идеялары/ойлору же өзүн өлтүрүү аракеттери жана өзүн өзү өлтүрүү менен потенциалдуу аяктаган), галлюцинациялар. Абдан сейрек – психотикалык реакциялар (өзүн өлтүрүү идеялары/ойлору же өзүн өлтүрүү аракеттери жана өзүн өзү өлтүрүүгө потенциалдуу алып келүүчү). Жыштыгы белгисиз – мания, анын ичинде гипомания.

Нерв системасы тарабынан бузулуулар: Көп эмес – баш оору, баш айлануу, уйкунун бузулуусу, даамдын бузулуусу. Сейрек – пар- жана дизестезия, гипозестезия, титирөө, карышуулар (анын ичинде эпилептикалык статус), баш айлануу. Абдан сейрек – шакый, координациянын бузулуусу, басыктын бузулуусу, жыт сезүү нервинин оорулары, баш сөөк ичиндеги гипертензия жана баш мээнин жалган шишимиги. Жыштыгы белгисиз – четки невропатия жана полинейропатия.

*Көрүү органы тарабынан бузулуулар *:* Сейрек – көрүүнүн бузулуулары (мисалы, кош көрүнүү). Абдан сейрек – визуалдык түстөрдү бурмалоо.

Угуу органы жана лабиринт тарабынан бузулуулар: Сейрек – кулактын шуулдашы, укпай калуу / угуунун бузулуусу.

*Жүрөк тарабынан бузулуулар **:* Сейрек – тахикардия. Жыштыгы белгисиз – Карынча аритмиясы жана "пируэт" тибиндеги полиморфтуу карынча тахикардиясы (көбүнчө QT аралыгынын узаруу коркунуч фактору бар бейтаптарда), ЭКГда QT аралыгынын узаруусу.

*Кан тамырлар тарабынан бузулуулар **:* Сейрек – вазодилатация, гипотензия, эси ооп калуу. Абдан сейрек – васкулиттер.

Дем алуу органдары, көкүрөк клеткасы жана орто көңдөй тарабынан бузулуулар: Сейрек – антигүү (анын ичинде астматикалык абал)

Ашказан-ичеги жолу тарабынан бузулуулар: Тез-тез – көңүл айнуу, ич өтүү. Көп эмес – кусуу, ашказан-ичеги жана ич оорулары, диспепсия, ич көбүү. Сейрек – антибиотикке-ассоциацияланган колит (абдан сейрек өлүмгө алып келиши мүмкүн). Абдан сейрек – панкреатит.

Боор жана өт бөлүп чыгаруу жолдору тарабынан бузулуулар: Көп эмес – трансаминазалардын көбөйүүсү, билирубиндин жогорулашы. Сейрек – боор алсыздыгы, холестатикалык сарык, гепатит. Абдан сейрек – боор некрозу (абдан сейрек өмүр үчүн коркунучтуу болгон боор алсыздыгына чейин күчөгөн).

Тери жана тери алдындагы клетчатка тарабынан бузулуулар: Көп эмес – бөртмө, кычышуу, бөрү жатыш.

Сейрек - жарыкка сезгичтик реакциялары. Абдан сейрек - петехия көп формалуу эритема, түйүндүү эритема, Стивенс-Джонсон синдрому (өмүр үчүн потенциалдуу коркунучтуу), токсиндүү эпидермалык некролиз (өмүр үчүн потенциалдуу коркунучтуу). Жыштыгы белгисиз – курч жайылган экзантематоздуу ириңдүү исиркек (AGEP), эозинофилия жана системалуу симптомдор менен дары реакциясы (DRESS).

Скелеттик-булчуң жана байланыштыргыч ткандар тарабынан бузулуулар: Көп эмес – скелеттик-булчуң оорусу (мисалы, колу-буттун оорусу, арканын оорусу, көкүрөктүн оорусу), артралгия. Сейрек – миалгия, артрит, булчуңдун жыйрылуу ыргагынын жогорулашы жана карышуулар. Абдан сейрек – булчуң алсыздыгы, тендинит, тарамыштардын үзүлүүсү (көбүнчө ахиллов тарамышы), миастения симптомдорунун күчөшү.

Бөйрөк жана заара бөлүп чыгаруу жолдору тарабынан бузулуулар: Көп эмес – бөйрөк алсыздыгы. Сейрек – бөйрөк алсыздыгы, гематурия, кристаллурия, тубулоинтерстициалдык нефрит.

Жалпы бузулуулар жана куйган жердеги бузулуулар: Көп эмес – астения, калтыратма. Сейрек – шишимик, терчилдик (гипергидроз).

Изилдөөлөр: Көп эмес – канда шакардуу фосфатаза денгээлинин жогорулашы. Сейрек - амилазанын жогорулашы. Жыштыгы белгисиз – эл аралык нормаланган катыштын жогорулашы (К витамининин антогонисттерин алган бейтаптарда).

* Бир нече кээде органдар системасынын бир нече классына жана сезүү органдарына (анын ичинде тендинит, тарамыштын үзүлүшү, артралгия, кол-буттардын оорушу, басыктын бузулушу сыяктуу) сезимдин бузулушу менен байланышкан невропатия, чүнчүү, алсыздык, эс тутумдун бузулушу, уйкунун бузулушу жана угуунун, көрүүнүн, даам сезүүнүн жана жыт сезүүнүн бузулушуна таасир берген хинолондорду жана фторхинолондорду колдонуу менен өз ара байланышкан өтө сейрек, узакка созулган (ай же жыл бою уланган), майып кылуучу, потенциалдуу кайтарымсыз олуттуу дары реакциялар айрым учурларда мурдагы коркунуч факторлору болгондугуна карабастан катталган.

** Фторхинолондорду алган бейтаптарда аневризм жана кээде үзүлүү менен оорлошкон аортанын кабаттануусу (анын ичинде өлүмгө учураткан), ошондой эле регургитация/жүрөк клапандарынын кайсы биринин алсыздыгы учурлары тууралуу маалымдалган.

Балдар популяциясы

Жогоруда айтылган артропатия (артралгия, артрит) оорусу чоң адамдар катышкан изилдөөлөрдөн алынган маалыматтарга кирет. Артропатия балдарда көп пайда болгону маалымдалган.

Ашыкча доза:

12 г дозасынан ашыруу уулануунун жеңил симптомдоруна алып келери маалымдалган. 16 г курч дозасынан ашыруу курч бөйрөк алсыздыгын пайда кылары маалымдалган.

Дозасынан ашыруунун симптомдоруна баш айлануу, титирөө, баш оору, чарчоо, карышуу, галлюцинациялар, акыл-эстин чаташуусу, иктеги ыңгайсыздык, бөйрөк жана боор алсыздыгы, ошондой эле кристаллурия жана гематурия кирет. Калыбына келме бөйрөк токсиндүүлүгү тууралуу маалымдалган.

Адаттагы шашылыш чаралардан, б.а. кийин медициналык углеводду куюу менен ашказанды бошотуудан тышкары бөйрөк функциясын, анын ичинде зааранын pH

көзөмөлдөө жана зарыл болсо кристаллурияны алдын алуу үчүн аны кычкылдантуу сунушталат. Бейтаптар жакшы гидратацияланышы керек. Кальций же магний камтыган антациддер ашыкча дозада ципрофлоксациндин сиңүүсүн теоретикалык төмөндөтүшү мүмкүн.

Гемодиализде же перитонеалдык диализде ципрофлоксациндин бир аз гана өлчөмү (<10%) бөлүнүп чыгышы мүмкүн.

Дозасынан ашырган учурда оору белгилерине жараша дарылоону жүргүзүү керек. QT аралыгынын узаруу мүмкүндүгүнөн улам ЭКГ мониторингин жүргүзүү керек.

Дарылык өз ара таасирлери:

Ципрофлоксацинге башка препараттардын таасири:

QT аралыгын узартуучу препараттар

QT аралыгын узартуучу препараттарды (мисалы, IA жана III классындагы аритмияга каршы препараттар, трициклиттик антидепрессанттар, макролиддер, нейролептиктер) алган бейтаптарда ципрофлоксацинди, башка фторхинолондор сыяктуу эле этияттык менен колдонуу керек.

Хелаттык комплекстин түзүлүшү

Ципрофлоксацинди (пероралдуу) жана препараттарды жана минералдык кошулмаларды (мисалы, кальций, магний, алюминий, темир) камтыган поливаленттүү катиондор, полимердик фосфат бириктирүүчү препараттар (мисалы, севеламер же лантан карбонаты), сукральфат же антациддер, ошондой эле магний, алюминий же кальций камтыган жогору буфердик препараттарды (мисалы, диданозин таблеткалары) бир убакта ичүү ципрофлоксациндин сиңүүсүн төмөндөтөт. Демек, ципрофлоксацинди бул препараттардан 1-2 саат мурун, же андан кийин 4 сааттан кем эмес убакытта куюу керек. Чектөө H₂-рецепторлорунун блокаторлор классына кирген антациддерге жайылтылбайт.

Тамак-аш азыктары жана сүт азыктары

Тамактын курамындагы диеталык кальций сиңирүүгө олуттуу таасир бербейт. Бирок сүт азыктарын же минералдар менен байытылган суусундуктарды (мисалы, сүт, йогурт, кальций менен байытылган апельсин ширеси) ципрофлоксацин менен бир убакта ичүүдөн алыс болуу керек, себеби ципрофлоксациндин сиңүүсү төмөндөшү мүмкүн.

Пробенецид

Пробенецид ципрофлоксациндин бөйрөк секрециясына тоскоолдук кылат. Пробенецидди жана ципрофлоксацинди бир убакта кабыл алуу кан сары суусунда ципрофлоксациндин концентрациясын жогорулатат.

Метоклопрамид

Метоклопрамид ципрофлоксациндин (пероралдуу) сиңүүсүн тездетет, бул кан плазмасында эң жогорку концентрацияга жетүү убактысынын кыскаруусуна алып келет. Ципрофлоксациндин биожеткиликтүүлүгүнө таасири байкалган эмес.

Омепразол

Ципрофлоксацинди жана омепразол камтыган дары каражаттарын бир убакта кабыл алуу ципрофлоксациндин C_{max} жана AUC бир аз төмөндөшүнө алып келет.

Ципрофлоксациндин башка дары каражаттарына таасири:

Тизанидин

Тизанидинди ципрофлоксацин менен бирге куюуга болбойт. Дени сак ыктыярчылар катышкан клиникалык изилдөөдө бир убакта кабыл алууда сары сууда тизанидиндин ципрофлоксацин менен концентрациясынын көбөйгөнү (C_{max} көбөйүүсү: 7 эсе,

диапазону: 4 төн 21 эсеге чейин; AUC көбөйүүсү: 10 эсе, диапазону: 6дан 24 эсеге чейин) байкалган. Сары сууда тизанидиндин концентрациясынын жогорулашы күчөтүлгөн гипотензивдүү жана тынч алдыруучу таасири менен байланыштуу.

Метотрексат

Метотрексатты бөйрөк түтүгү аркылуу ташуу ципрофлоксацинди бир убакта куюуда басаңдатылышы мүмкүн, бул кан плазмасында метотрексаттын деңгээлинин жогорулашына жана метотрексат менен байланышкан токсиндүү реакциялардын көбөйүүсүнө алып келиши мүмкүн. Бир убакта кабыл алуу сунушталбайт.

Теofilлин

Ципрофлоксацинди жана теofilлинди бир убакта кабыл алуу кан сары суусунда теofilлиндин концентрациясынын жагымсыз жогорулашын пайда кылышы мүмкүн. Бул теofilлинден пайда болгон кыйыр таасирлерге алып келиши мүмкүн, алар сейрек өмүргө коркунуч туудурушу же өлүмгө алып келиши мүмкүн. Айкалыштырган мезгилде кан сары суусунда теofilлиндин концентрациясын көзөмөлдөө жана зарыл болсо теofilлиндин дозасын төмөндөтүү керек.

Башка ксантинден алынгандар

Ципрофлоксацинди жана кофеинди же пентоксифиллинди (окспентифиллинди) бир убакта кабыл алууда кан сары суусунда бул ксантинден алынгандардын концентрациясынын жогорулаганы тууралуу маалымдалган.

Фенитоин

Ципрофлоксацинди жана фенитоинди бир убакта куюу кан сары суусунда фенитоиндин деңгээлинин жогорулашына же төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн, ошондуктан препараттын деңгээлин көзөмөлдөө сунушталат.

Циклоспорин

Ципрофлоксацинди жана циклоспорин камтыган дары каражаттарын бир убакта кабыл алууда кан сары суусунда креатининдин концентрациясынын транзитордук жогорулашы байкалган. Ошондуктан мындай бейтаптарда кан сары суусундагы креатининдин концентрациясын тез-тез (жумасына эки жолу) көзөмөлдөө зарыл.

К витамининин антогонисттери

Ципрофлоксацинди К витамининин антогонисттери менен бир убакта кабыл алуу анын антикоагулянттык таасирин күчөтүшү мүмкүн. Коркунучу негизги инфекциядан, курактан жана бейтаптын жалпы абалына жараша өзгөрүп турушу мүмкүн, ошондуктан ципрофлоксациндин INR (эл аралык нормаланган катышы) жогорулашына салымын баалоо кыйын. Ципрофлоксацинди К витамининин антогонисттери (мисалы, варфарин, аценокумарол, фенпрокумон же флуиндион менен) менен бир убакта кабыл алуу убагында жана андан кийин көп өткөрбөй INR тез-тез көзөмөлдөө керек.

Дулоксетин

Клиникалык изилдөөлөрдө дулоксетинди флувоксамин сыяктуу CYP450 1A2B изоферментинин күчтүү басаңдаткычтары менен бир убакта кабыл алуу дулоксетиндин AUC жана Cmax көбөйүүсүнө алып келиши мүмкүн экендиги көрсөтүлгөн. Ципрофлоксацин менен өз ара таасиринин мүмкүндүгү тууралуу клиникалык маалыматтар жок болсо да, ушуга окшогон таасирлерди бир убакта кабыл алууда күтүүгө болот.

Ропинирол

Клиникалык изилдөөлөрдө ропиниролду CYP450 1A2 изоферментинин орточо басаңдаткычы ципрофлоксацин менен бир убакта кабыл алуу ропиниролдун Cmax жана AUC ылайыгына жараша 60% жана 84% көбөйүшүнө алып келгени көрсөтүлгөн.

Ропиниролго байланышкан кыйыр таасирлерди көзөмөлдөө сунушталат, жана зарыл болсо ципрофлоксацин менен бир убакта кабыл алуу убагында жана андан кийин көп өткөрбөй дозасын тууралоо сунушталат.

Лидокаин

Дени сак ыктыярчыларда лидокаин камтыган дары каражаттарын CYP450 1A2 изоферментинин орточо басаңдаткычы ципрофлоксацин менен бир убакта кабыл алуу тамыр ичине лидокаиндин клиренсин 22%га төмөндөткөнү көрсөтүлгөн. Лидокаин менен дарылоонун көтөрүмдүүлүгү жакшы болсо да, бир убакта кабыл алууда кыйыр таасирлери менен байланышкан ципрофлоксацин менен өз ара таасири мүмкүн.

Клозапин

250 мг ципрофлоксацинди клозапин менен 7 күн бою бир убакта ичүүдөн кийин сары сууда клозапиндин жана N-десметилклозапиндин концентрациялары ылайыгына жараша 29% жана 31% жогорулаган. Ципрофлоксацин менен бир убакта кабыл алуу мезгилинде жана андан кийин көп өткөрбөй клозапиндин дозасын тууралоо жана клиникалык байкоо сунушталат.

Силденафил

Дени сак ыктыярчыларда 500 мг ципрофлоксацинди бир убакта 50 мг пероралдуу ичкенден кийин силденафилдин Cmax жана AUC болжолдуу эки эсеге көбөйгөн. Ошондуктан ципрофлоксацинди бир убакта силденафил менен коркунучтарын жана артыкчылыктарын эске алып, этияттык менен дайындоо керек.

Агомелатин

Клиникалык изилдөөлөрдө флувоксамин CYP450 1A2 изоферментинин күчтүү басаңдаткычы катары агомелатиндин зат алмашуусун байкаларлык басаңдатканы көрсөтүлгөн, бул агомелатиндин таасиринин 60 эсеге көбөйүшүнө алып келет. CYP450 1A2 изоферментинин орточо басаңдаткычы ципрофлоксацин менен өз ара таасиринин мүмкүндүгү тууралуу клиникалык маалыматтар жок болсо да, бир убакта кабыл алууда ушуга окшогон таасирлерди күтүүгө болот.

Золпидем

Ципрофлоксацинди бир убакта ичүү канда золпидемдин деңгээлин жогорулатышы мүмкүн, бир убакта кабыл алуу сунушталбайт.

Өзгөчө көрсөтмө:

Хинолондорду же фторхинолондорду камтыган препараттарды колдонууда олуттуу кыйыр реакциялар мурун байкалган бейтаптарга ципрофлоксацинди колдонуудан алыс болуу керек. Мындай бейтаптарды ципрофлоксацин менен дарылоону альтернативдүү варианттардын жок болушунда жана коркунуч/пайдасын тыкыр балоодон кийин гана баштоо керек.

Оор инфекциялар жана грам оң жана анаэробдуу козгогучтар менен аралаш инфекциялар
Оор инфекцияларды жана грам оң же анаэробдуу козгогучтардан пайда болгон инфекцияларды дарылоо үчүн ципрофлоксацин менен монодарылоо ылайыктуу эмес. Мындай инфекцияларда ципрофлоксацинди башка тиешелүү бактерияга каршы каражаттар менен бир убакта дайындоо керек.

Стрептококк инфекциялары (анын ичинде *Streptococcus pneumoniae*)

Ципрофлоксациндин натыйжалуулугу жетишсиз болгондуктан стрептококк инфекцияларын дарылоо үчүн сунушталбайт.

Жыныс жолдорунун инфекциялары

Гонококк уретрити, цервицит, эпидидимоорхит жана кичи жамбаш чарасынын органдарынын сезгенген оорулары фторхинолондорго туруктуу *Neisseria gonorrhoeae* изоляттары пайда кылышы мүмкүн. Ошентип, эгерде ципрофлоксацинге туруктуу *Neisseria gonorrhoeae* жокко чыгарууга мүмкүн болгон учурда гана ципрофлоксацинди гонококк уретритин же цервицитти дарылоо үчүн дайындоого болот.

Эпидидимоорхитте жана кичи жамбаш чарасынын органдарынын сезгенген ооруларында, эгерде ципрофлоксацинге туруктуу *Neisseria gonorrhoeae* жокко чыгарууга мүмкүн болбосо, эмпирикалык ципрофлоксацинди башка ылайыктуу бактерияга каршы каражат (мисалы, цефалоспорин) менен айкалышта гана кароо керек. Эгерде 3 күн дарылоодон кийин клиникалык жакшыруу болбосо, дарылоону кайра кароо керек.

Заара чыгаруучу түтүктүн инфекциялары

Escherichia coli – заара бөлүп чыгаруу жолдорунун инфекцияларын пайда кылуучу кеңири таралган козгогучтун фторхинолондорго туруктуулугу Европа Биримдигинин өлкөлөрүндө өзгөрүп турат. Дарыгерлерге *Escherichia coli* фторхинолондорго туруктуулугунун жергиликтүү таралышын эске алуу сунушталат.

Менопаузадагы аялдарда татаалдашпаган циститте колдонууга болгон ципрофлоксациндин бир жолку дозасы узагыраак созулган дарылоого караганда төмөнүрөөк натыйжалуулугу менен ассоциацияланышы күтүлөт. Муну хинолондорго ичеги таякчаларынын туруктуулук деңгээлинин жогорулашына байланыштуу көбүрөөк эске алуу керек.

Курсак ичиндеги инфекциялар

Операциядан кийинки курсак ичиндеги инфекцияларды дарылоодо ципрофлоксациндин натыйжалуулугу тууралуу чектелген маалыматтар бар.

Саякатчылардын ич өткөгү

Ципрофлоксацинди тандоодо барган өлкөлөрдө тиешелүү патогендердин ципрофлоксацинге туруктуулугу жөнүндө маалыматты эске алуу керек.

Сөөктөрдүн жана муундардын инфекциялары

Ципрофлоксацинди башка микробго каршы каражаттар менен айкалышта микробиологиялык документациянын жыйынтыктарына жараша колдонуу керек.

Сибирь жарасынын ингаляциялык формасы

Адамдарда колдонуу *in vitro* сезгичтиги тууралуу маалыматтарга жана жаныбарларга эксперименталдык маалыматтарга, ошондой эле адамдар тууралуу чектелген маалыматтарга негизделген. Дарылап жаткан дарыгерлер сибирь жарасын дарылоого карата улуттук жана/же эл аралык макулдашылган документтерге кайрылуулары керек.

Балдар популяциясы

Балдарда жана өспүрүмдөрдө ципрофлоксацинди колдонуу болгон расмий сунуштарга ылайык ишке ашырылышы керек. Ципрофлоксацин менен дарылоо балдарда жана өспүрүмдөрдө муковисцидозду жана/же оор инфекцияларды дарылоо тажрыйбасы бар дарыгерлер менен гана башталышы керек.

Ципрофлоксацин жыныстык жетиле элек жаныбарлардын жүк көтөрүүчү муундарында артропатияны пайда кылганы көрсөтүлгөн. Коопсуздугу боюнча рандомизацияланган кош жабык изилдөөнүн маалыматтарда балдарда ципрофлоксацинди колдонуу (ципрофлоксацин: n = 335, орточо курагы = 6,3 жаш; салыштыруу препараттары: n = 349, орточо курагы = 6,2 жаш; курактык диапозону = 1ден 17 жашка чейин) дары препараттары менен байланышкан (муундарга байланышкан клиникалык белгилери жана симптомдору боюнча аныкталуучу) +42 күнгө карата 7,2% жана 4,6% артропатияга күмөн саналган оору аныкталган. 1 жыл байкоодон кийин дарылык артропатиянын жыштыгы ылайыгына

жараша 9,0% жана 5,7% түзгөн. Дарылык артропатияга күмөн саноо учурларынын көбөйүшү убакыттын өтүшү менен топтор ортосунда статистикалык маанилүү эмес болгон. Дарылоону муундар жана/же тегерегиндеги ткандар менен байланышкан мүмкүн болуучу жагымсыз көрүнүштөрдөн улам пайда жана коркунуч катышын тыкыр балоодон кийин гана баштоо керек.

Муковисцидоздо колко өпкө инфекциялары

Клиникалык изилдөөлөргө 5-17 жаш курагындагы балдар жана өспүрүмдөр кирген. 1ден 5 жашка чейинки курактагы балдарда дарылоо тажрыйбасы көбүрөөк чектелген.

Заара бөлүп чыгаруу жолдорунун татаалдашкан инфекциялары жана пиелонефрит

Заара бөлүп чыгаруу жолдорунун инфекцияларын ципрофлоксацин менен дарылоону дарылоонун башка ыкмаларын колдонууга мүмкүн эмес болгондо кароо керек, жана ал микробиологиялык изилдөөнүн жыйынтыктарына негизделүүгө тийиш.

Клиникалык изилдөөлөргө 1 жаштан 17 жашка чейинки курактагы балдар жана өспүрүмдөр кирген.

Башка өзгөчө оор инфекциялар

Башка оор инфекциялар расмий сунуштамаларга ылайык же дарылоонун башка ыкмаларын колдонууга мүмкүн эмес болгондо, коркунуч жана пайдасын тыкыр балоодон кийин, же салттуу дарылоонун натыйжасыздыгынан кийин жана микробиологиялык документация ципрофлоксацинди колдонууну актаган учурда.

Жогоруда айтылгандардан тышкары айрым оор инфекцияларда ципрофлоксацинди колдонуу клиникалык изилдөөлөрдө бааланган эмес, жана клиникалык тажрыйбасы чектелген. Демек, бул инфекциялары бар бейтаптарды дарылоодо этияттыкты сактоо сунушталат.

Өтө сезгичтик

Өтө сезгичтик жана аллергиялык реакциялар, анын ичинде анафилаксия жана анафилактоиддик реакциялар бир жолу ичкенден кийин пайда болушу мүмкүн жана өмүр үчүн коркунучтуу болушу мүмкүн. Мындай реакция пайда болгондо ципрофлоксацинди ичүүнү токтотуу керек жана адекваттуу дарылоо талап кылынат.

Дарыга узакка созулган, инвалид кылуучу жана потенциалдуу калыбына келбеген олуттуу кыйыр реакциялар

Хинолондорду же фторхинолондорду алган бейтаптарда, алардын курагына жана мурдагы коркунуч факторлоруна көз карандысыз адамдын организмнин түрдүү, кээде бир нече системасына (сөөк-булчуң, нерв жана психикалык система, сезүү органдары) таасири бар, абдан сейрек узакка созулган (бир ай же жылга созулган), инвалид кылуучу, потенциалдуу калыбына келбеген олуттуу терс реакциялары өрчүгөндүгү тууралуу билдирүүлөр алынган. Бардык олуттуу жагымсыз реакцияларынын биринчи белгилери жана симптомдору пайда болушунда ципрофлоксацинди кабыл алууну дароо токтотуу, жана бейтаптарга дарылап жаткан дарыгерине кеңеш алуу үчүн кайрылуусу керектигин айтуу керек.

Тендинит жана тарамыштардын үзүлүшү

Ципрофлоксацинди, эреже катары хинолондор менен дарылоого байланыштуу таржымалында тарамыштардын оорулары/бузулуулары бар бейтаптарга колдонууга болбойт. Ошондой болсо да, сейрек учурларда козгогучту микробиологиялык документтештиргенден жана коркунуч жана пайда катышын баалоодон кийин бул бейтаптарга кээ бир оор инфекцияларды дарылоо үчүн, өзгөчө стандарттык дарылоонун натыйжасыздыгы же бактериялык туруктуулук учурунда ципрофлоксацинди колдонууну микробиологиялык маалыматтар актаганда ципрофлоксацин дайындалышы мүмкүн.

Тендинит жана тарамыштардын үзүлүшү (өзгөчө, ахиллов тарамышы, бирок аны менен чектелбейт), кээде эки тараптуу, хинолондор жана фторхинолондор менен дарылоо башталгандан кийин 48 сааттан кийин эле, ошондой эле, маалымдалгандай дарылоону токтоткондон кийин бир нече айдан кийин да пайда болушу мүмкүн. Тендинит жана тарамыштардын үзүлүшүнүн коркунучу улгайган бейтаптарда, бөйрөк алсыздыгы бар бейтаптарда, паренхиматоздук органдары трансплантациялаган бейтаптарда жана кортикостероиддерди бир убакта алган бейтаптарда жогору. Ошондуктан кортикостероиддерди бир убакта колдонуудан алыс болуу керек.

Тендиниттин биринчи белгилеринде (мисалы, ооруксунган шишимик, сезгенүү) ципрофлоксацин менен дарыланууну токтотуу жана альтернативдүү дарылоону кароо керек. Жабыркаган кол-буттарды тиешелүү түрдө дарылоо керек (мисалы, кыймылсыз жаткыруу). Тендинопатиянын белгилери пайда болушунда кортикостероиддерди колдонууга болбойт.

Миастениясы бар оорулуулар

Миастения грависи бар бейтаптарга ципрофлоксацинди этияттык менен колдонуу керек, себеби симптомдору күчөшү мүмкүн.

Аортанын аневризмасы жана кабаттанышы, регургитация/жүрөк клапанынын алсыздыгы

Эпидемиологиялык изилдөөлөр, өзгөчө улгайган курактагы бейтаптарда, ошондой эле фторхинолондорду колдонгондон кийин аортанын жана митралдык клапандын жетишсиздиги, аневризманын жана аортанын кабатталышы өрчүү жогору коркунучу тууралуу маалымдаган. Фторхинолондорду алган бейтаптарда аневризма жана аортанын кабаттанышы, кээде үзүлүү менен оорлошкон (анын ичинде өлүмгө учураткан) учурлары, жана регургитация/жүрөктүн кайсы бир клапанынын жетишсиздиги тууралуу маалымдалган.

Демек, фторхинолондорду пайда жана коркунуч катышын тыкыр баалагандан кийин жана үй-бүлөлүк оң таржымалында аневризмасы же жүрөк клапандарынын тубаса кемтиктери, же аортанын аневризмасы жана/же кабатталышы же аортанын аневризмасы жана/же кабатталышы диагнозу мурун болгон бейтаптарда, же жүрөк клапанынын оорусу, же коркунучтун башка факторлорунун болушу же төмөнкүлөргө жакындатуучу абалдарда дарылоонун башка варианттарын карагандан кийин гана колдонуу керек:

- аортанын аневризмасы жана кабатталышы үчүн сыяктуу эле жана регургитация/ жүрөк клапанынын жетишсиздигинде, (мисалы, Марфан синдрому же Элерс-Данлос синдрому, Тернер синдрому, Бехчет оорусу, гипертония, ревматоиддик артрит сыяктуу байланыштыргыч ткандардын бузулуулары) же кошумча;

- аортанын аневризмасы жана кабатталышы (мисалы, Такаясу артериити же ири клеткалуу артериит, же белгилүү атеросклероз, же Шегрен синдрому сыяктуу кан тамыр бузулуулары) же кошумча

- жүрөк клапанынын регургитациясы/жетишсиздиги (мисалы, инфекциялык эндокардит).

Аортанын аневризмасы жана кабатталышы, ошондой эле алардын үзүлүү коркунучу системалуу кортикостероиддерди бир убакта алган бейтаптарда ошондой эле жогорулашы мүмкүн.

Ичте, көкүрөктө же аркада капыстан оору пайда болгон учурда бейтаптарга дароо тез жардам бөлүмүнө дарыгерге кайрылуу керек.

Бейтаптарга курч демигүү, жүрөктүн тез-тез согушунун жаңы пристубу же ичтин же буттардын шишимиги өрчүгөн учурда медициналык жардамга токтоосуз кайрылууну сунуштоо керек.

Көрүүнүн бузулуусу

Көрүүнүн бузулуусунда же көзгө кандайдыр бир таасиринде дароо окулистке кайрылуу керек.

Жарыкка сезгичтик

Ципрофлоксацин жарыкка сезгичтик реакцияларын пайда кылары көрсөтүлгөн. Ципрофлоксацинди кабыл алган бейтаптарга дарылануу мезгилинде интенсивдүү түз тийген күндүн нурунан же УК–нурлануусунан алыс болууну сунуштоо керек.

Карышуулар

Ципрофлоксацин башка хинолондор сыяктуу эле карышууларды пайда кылат, же карышуу чегин төмөндөткөнү белгилүү. Эпилептикалык статус тууралуу учурлар маалымдалган. Ципрофлоксацинди карышууларга жакындыгы болушу мүмкүн, БНС бузулуулары бар бейтаптарда этияттык менен колдонуу керек. Карышуулардын пайда болушунда ципрофлоксацинди ичүүнү токтотуу керек.

Четки нейропатия

Хинолондорду жана фторхинолондорду алган бейтаптарда парестезия, гипестезия, дизестезия же алсыздыкка алып келүүчү сенсордук же сенсомотордук полинейропатия учурлары тууралуу маалымдалган. Ципрофлоксацин менен дарылоону алган бейтаптарга дарылоону улантардын алдында ооруу, ачышуу, сайгылашуу, уюп калуу же алсыздык сыяктуу нейропатиянын симптомдору пайда болсо, потенциалдуу калыбына келбеген абалдардын өрчүшүн алдын алуу үчүн өзүнүн дарыгерине маалымдоо керектигин сунуштоо керек.

Психиатриялык реакциялар

Психикалык реакциялар ципрофлоксацинди биринчи куйгандан кийин да пайда болушу мүмкүн. Сейрек учурларда чүнчүү же психоз өзүн өлтүрүү идеялары/ойлоруна, өзүн өлтүрүү аракети же өзүн өзү өлтүрүү менен аяктаганга чейин күчөшү мүмкүн. Чүнчүү, психотикалык реакциялар, өзүн өлтүрүү ойлору же жүрүм-турумдар пайда болушунда ципрофлоксацинди ичүүнү токтотуу керек.

Жүрөк бузулуулары

Фторхинолондорду, анын ичинде ципрофлоксацинди төмөнкү QT аралыгынын узаруу белгилүү коркунуч факторлору бар бейтаптарга колдонууда этияттыкты сактоо керек, мисалы:

- QT аралыгынын тубаса узаруу синдрому;
- QT аралыгын узартууну пайда кылышы белгилүү болгон препараттарды бир убакта колдонуу (мисалы, IA класстагы жана III класстагы аритмияга каршы препараттар, трициклиттик антидепрессанттар, макролиддер, нейролептиктер);
- электролит балансынын түзөтүлбөгөн бузулуулары (мисалы, гипокалиемия, гипомagneмия);
- жүрөк оорулары (мисалы, жүрөк жетишсиздиги, миокард инфаркты, брадикардия).

Улгайган курактагы бейтаптар жана аялдар QTc аралыгын узартуучу препараттарга көбүрөөк сезгич болушу мүмкүн. Ошондуктан, фторхинолондорду, анын ичинде ципрофлоксацинди, бул топтогу бейтаптарга колдонууда этияттыкты сактоо керек.

Дисгликемия

Бардык хинолондор сыяктуу эле, кандагы глюкоза деңгээлдеринин бузулуулары, анын ичинде гипергликемия, ошондой эле гипогликемия сыяктуулар, адатта пероралдуу гипогликемиялык каражаттарды (мисалы, глибенкламид) же инсулинди коштоп дарылоо алган диабети бар бейтаптарда маалымдалган. Гипогликемиялык кома учурлары тууралуу маалымдалган. Кант диабети бар оорулууларга кандагы глюкоза деңгээлин дыкат көзөмөлдөө сунушталат.

Ашказан-ичеги системасы

Оор жана туруктуу ич өткөктү дарылоо учурунда же андан кийин пайда болуусу (анын ичинде дарылоодон кийин бир нече жумадан кийин) шашылыш дарылоону талап кылган антибиотикке ассоциацияланган колиттин (өлүмгө учуратуу мүмкүндүгү менен өмүргө коркунуч келтирген) болушуна көрсөтүшү мүмкүн. Мындай учурларда ципрофлоксацинди колдонууну токтотуу жана тиешелүү дарылоону баштоо керек. Мындай кырдаалда перистальтикага каршы препараттар каршы көрсөтүлөт.

Бөйрөк жана заара бөлүп чыгаруу системасы

Ципрофлоксацинди колдонууга байланышкан кристаллурия тууралуу маалымдалган. Ципрофлоксацинди алган бейтаптар жетиштүү өлчөмдө суюктук алуулары керек, жана зааранын ашыкча шакардуулугунан алыс болуу керек.

Бөйрөк функциясынын бузулуусу

Ципрофлоксацин негизинен өзгөрбөгөн формада бөйрөктөр менен бөлүнүп чыккандыктан, бөйрөк функциясынын бузулуулары бар бейтаптарга ципрофлоксациндин топтолуусунан пайда болгон кыйыр реакциялардын күчөшүнөн алыс болуу үчүн дозасын тууралоо зарыл.

Гепатобилиардык система

Ципрофлоксацинди колдонууда боор некрозунун жана өмүргө коркунуч келтирген боор алсыздыгы учурлары тууралуу маалымдалган. Боор оорусунун кандайдыр бир симптомдору пайда болгон учурда (табиттин жоктугу, сарык, зааранын карарышы, кычышуу же ичтин ооруксунушу сыяктуу) дарылоону токтотуу керек.

Глюкоза-6-фосфат дегидрогеназа жетишсиздиги

Ципрофлоксацинди колдонууда глюкоза-6-фосфат дегидрогеназа жетишсиздиги бар бейтаптарда гемолитикалык реакциялар тууралуу маалымдалган. Мындай бейтаптарга потенциалдуу пайда күтүлгөн коркунучтан ашат деп эсептелген учурларды кошпогондо, ципрофлоксацинди колдонуудан алыс болуу керек. Мындай учурда гемолиздин пайда болуу мүмкүндүгүн көзөмөлдөө керек.

Туруктуулугу

Ципрофлоксацин менен дарылоо курсу убагында же андан кийин ципрофлоксацинге туруктуулугун көрсөткөн бактериялар клиникалык айкын же айкын эмес суперинфекциялар менен белгилениши мүмкүн. Узакка дарылоодо жана нозокомиалдык инфекцияларды жана/же *Staphylococcus* жана *Pseudomonas* түрлөрүнөн пайда болгон инфекцияларда ципрофлоксацинге туруктуу бактерияларды тандоодо өзгөчө коркунуч пайда болушу мүмкүн.

Цитохрома P450

Ципрофлоксацин CYP1A2 басандатат жана, ошентип бул фермент менен зат алмашуучу бир убакта колдонулган заттардын (мисалы, теофиллиндин, клозапиндин, оланзапиндин, ропиниролдун, тизанидиндин, дулоксетиндин, агомелатиндин) сары суудагы концентрациясынын жогорулашын пайда кылышы мүмкүн. Демек, бул заттарды ципрофлоксацин менен бир убакта кабыл алган бейтаптарды дозасынан ашыруунун

клиникалык белгилеринин пайда болушуна тыкыр байкоо алдында болуулары керек, жана сары сууда концентрацияларын аныктоо талап кылынышы мүмкүн (мисалы, теофиллиндин).

Ципрофлоксацинди жана тизанидинди бир убакта колдонуу каршы көрсөтүлөт.

Метотрексат

Ципрофлоксацинди метотрексат менен бир убакта колдонуу сунушталбайт.

Тесттер менен өз ара таасири

Mycobacterium tuberculosis карата ципрофлоксациндин активдүүлүгүн *in vitro* изилдөөдө азыркы учурда ципрофлоксацин кабыл алган бейтаптардан алынган үлгүлөрдө бактериологиялык тесттер жалган терс жыйынтыктарды бериши мүмкүн.

Көмөкчү заттар тууралуу маалымат

Сахарозалык жүктөм

Фруктозага көтөрүмсүздүк, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы же сахароза-изомальтаза жетишсиздиги сейрек тукум куучу көйгөйлөрү бар бейтаптарга Форцип 125 мг/5 мл кабыл алууга болбойт. Себеби Форцип 125 мг/5 мл суспензиясы сахарозаны камтыйт. Муну кант диабети бар бейтаптарга эске алуу керек. Форцип 125 мг/5 мл тиштерге зыян келтириши мүмкүн.

Кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгили:

Кош бойлуулук:

Кош бойлуу аялдарга ципрофлоксацинди дайындоо боюнча маалыматтар ципрофлоксациндин өрчүүдө кемтиктердин же фето/неонаталдык токсиндүүлүгүнүн жоктугун көрсөткөн. Жаныбарларда изилдөөлөр репродуктивдүү токсиндүүлүккө карата түз же кыйыр таасирин көрсөткөн эмес. Жаш жана туулганга чейинки хинолондордун таасирине тушуккан жаныбарларда жетиле элек кемирчекке таасири байкалган, ошондуктан препарат адамдын жетиле элек организмнин /түйүлдүктүн муун кемирчектерин жабыркашын пайда кылышы мүмкүндүгүн жокко чыгарууга болбойт. Ошондуктан кош бойлуу мезгилде ичүү үчүн суспензия түрүндөгү Форципти кабыл алуу сунушталбайт.

Бала эмизүү мезгили:

Ципрофлоксацин эне сүтү менен бөлүнүп чыгат. Жаныбарлар тууралуу маалыматтарга негизделген муун кемирчектеринин жабыркашы потенциалдуу коркунучунан улам, жана эне сүтүн эмген бала үчүн коркунучту жокко чыгарууга болбойт, эне сүтүн эмизүү мезгилинде Форцип пероралдуу суспензиясы сунушталбайт.

Авто унааны же башка механизмдерди башкарууда реакциянын тездигине таасир берүү жөндөмдүүлүгү.

Ципрофлоксацин өзүнүн неврологиялык таасирлеринен улам реакция мезгилинде таасир бериши мүмкүн. Ошентип автомобилди башкаруу жана механизмдер менен иштөө жөндөмдүүлүгү бузулушу мүмкүн.

Чыгаруу формасы:

Янтарь түстөгү айнек бөтөлкөдө 60 мл ичип кабыл алуу үчүн суспензия.

Бир бөтөлкө 15 мл ченем стаканы жана медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон таңгакчада.

Сактоо шарты:

Кургак, жарык тийбеген жерде 25°C дан жогору эмес аба табында сакталат.
Балдар жетпеген жерде сактоо керек.
Тондурууга болбойт!

Жарактуулук мөөнөтү: 3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты: Дарыгердин рецепти боюнча.

Соода маркасынын жана каттоо күбөлүгүнүн ээси:

Vegapharm LLP

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park,
London, England, SE10 9QF, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү:

Lark Laboratories (India) Ltd.

SP-1192 E, Phase-IV, RIICO Industrial Area,
Bhiwadi, Distt. Alwar (Rajasthan), India (Индия)

**Кыргыз Республикасынын аймагында керектөөчүлөрдөн продукциянын (товардын)
сапаты боюнча арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги**

«Aman Pharm» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,
Шооруков көч, 36.

Тел.: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com